Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95080-155 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5020177-34.2025.8.21.0010/RS

AUTOR: LENISEA PEREIRA TOMASI

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

LENISEA PEREIRA TOMASI, qualificada na inicial, ajuizou ação de obrigação de fazer contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.**, também qualificada.

Narrou que é portadora de FIBROMIALGIA (CID-10 M79.7), TRANSTORNO DO PÂNICO (CID-10 F41.0), EPISÓDIOS DEPRESSIVOS (CID-10 F32.8), INSÔNIA CRÔNICA e DISTÚRBIOS DO SONO (CID-10 G47), CANSAÇO e FADIGA (CID-10 R53) e CONSTIPAÇÃO FUNCIONAL (CID-10 K59.0). Afirmou que, devido ao seu quadro clínico, os tratamentos medicamentosos convencionais, incluindo ansiolíticos, antidepressivos como duloxetina e pregabalina, não apresentaram resposta terapêutica satisfatória, causando efeitos colaterais como sedação e desânimo, que agravaram seus sintomas. Diante da ineficácia dos tratamentos anteriores, seu médico assistente, Dr. Marcelo Bonanza, prescreveu terapia com cannabis medicinal. Referiu que o tratamento indicado é o CBD UP LINE ISOSPEC ENTOURAGE FULL SPECTRUM, 0,2% DE THC 6000MG – 200MG/ML, em frascos de 30ml, sendo necessários 12 frascos ao ano, com um custo total anual de R$ 21.470,00, valor que não possui condições financeiras de arcar. Mencionou que, apesar da prescrição médica e da autorização de importação concedida pela ANVISA, a ré negou a cobertura do tratamento, alegando que o medicamento é de uso domiciliar, experimental para a patologia indicada (*off-label*) e que existem outras alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Defendeu a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, discorrendo sobre o direito aplicável. Requereu a concessão da tutela de urgência para o fornecimento do medicamento prescrito, pelo tempo determinado pelo médico. Ao final, pediu a procedência da ação, com a confirmação da tutela antecipada e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. Atribuiu à ré os ônus sucumbenciais. Deu à causa o valor de R$41.470,00. Juntou documentos - Evento 1.

Foi deferido o benefício da AJG à autora e indeferida a tutela de urgência - Evento 9. Da decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para fins de conceder a tutela de urgência pleiteada, e compelir a agravada ao fornecimento do medicamento no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de valores - Evento 18.

Citada, a demandada contestou - Evento 24. Preliminarmente, impugnou o valor da causa. No mérito, alegou que a autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e pelas normas da ANS. Sustentou que a negativa de cobertura se deu por ausência de previsão legal e contratual para medicamentos de uso domiciliar e para uso *off-label*. Afirmou que o inciso VI do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde permite expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto antineoplásicos orais, e que o contrato da autora reflete essa exclusão. Citou a RN/ANS nº 465/2021 e o Enunciado nº 117 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ para corroborar sua tese. Argumentou, ainda, que a inexistência de comprovação científica robusta sobre a eficácia do tratamento para as patologias indicadas reforça seu caráter experimental, legitimando a recusa. Por fim, defendeu a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado. Requereu a extinção do processo ou a improcedência da ação. Juntou documentos.

Houve réplica - Evento 31.

Foi rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa - Evento 35.

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É o relatório. Decido.

Cabível o julgamento antecipado do feito no estado em que se encontra, na hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as partes não postularam outras provas.

A pretensão da parte autora é de que a ré seja obrigada a fornecer o medicamento cannabis medicinal - CBD UP LINE ISOSPEC ENTOURAGE FULL SPECTRUM, 0,2% DE THC 6000MG –, em face do diagnóstico de: CID-10: M79.7 – Fibromialgia F41.0 – Transtorno do Pânico distúrbio de sono, insônia crônica , G47 - Distúrbios do sono ; INSONIA CRONICA ; F32.8 – Episódios depressivos leves e persistentes R53 – Cansaço e fadiga K59.0 – Constipação funcional, conforme indicado pelo médico assistente -Evento 1, LAUDO12.

A demandada, por sua vez, referiu que o plano de saúde da autora não possui cobertura para medicamento com caráter domiciliar.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor:

Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nestas circunstâncias, o art. 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, inciso IV, § 1°, inciso II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Consoante o laudo do médico assistente, Dr. Marcelo Bonanza (Evento 1, LAUDO12), a autora tem diagnóstico de Fibromialgia (CID-10 M79.7), Transtorno do Pânico (CID-10 F41.0), Episódios Depressivos (CID-10 F32.8), Insônia Crônica e Distúrbios do Sono (CID-10 G47). O profissional justifica a prescrição da terapia com cannabis medicinal pela ineficácia de tratamentos anteriores e ressalta que a não utilização acarretará riscos de "regressões neurológicas graves e irreversíveis".

No caso, o pedido de autorização para o fornecimento da medicação foi recusado sob a justificativa de que o medicamento é de uso oral e domiciliar, além de ser considerado *off-label* e experimental para a fibromialgia, existindo alternativas terapêuticas cobertas (evento 1, COMP14). Na contestação, a demandada reitera a negativa afirmando que há cláusula expressa afastando o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar.

Sobre o tratamento domiciliar, dispõe a Lei 9.656/1998:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)

Já o PARECER TÉCNICO Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS[1], assim prevê:

"(...) a Lei n.º 9.656/1998 deixa explícito, em seu artigo 10, inciso VI, que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias".

Ou seja, os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos para uso domiciliar, exceto os antineoplásicos orais ou medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. (...) 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. (...) 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. (...) 6.Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. RECURSO ESPECIAL Nº 1.883.654 - SP (2020/0170589-2). Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 02/08/2021.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE EMBOLIA PULMONAR SEM MENÇÃO DE COR PULMONALE AGUDOE DE DOENÇA CARDÍACA PULMONAR. MEDICAMENTO RIOCIGUATE (ADEMPAS). USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. 1) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 2) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 3) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 4) Caso dos autos em que o medicamento postulado, "Riociguate (ADEMPAS)", indicado pelo médico assistente do autor para o tratamento de embolia pulmonar sem menção de cor pulmonale agudo - CID 10 I.26.9 e outras formas de doença cardíaca pulmonar - CID 10 I27, pertence a classe dos medicamentos "Anti-Hipertensivos" e sua administração é de uso domiciliar.. 5) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, descabe compelir a operadora do plano de saúde à cobertura do medicamento domiciliar postulado. Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 6) Como decorrência lógica do julgamento de improcedência do pedido do autor, tem-se a revogação da tutela de urgência inicialmente deferida, o que atrai a obrigação da parte beneficiada com o provimento de suportar as quantias pagas em decorrência do fornecimento do medicamento no período em que vigoraram os efeitos da tutela. 7) Em que pese não seja possível a condenação da parte autora ao ressarcimentos dos valores suportados em virtude do deferimento de medida liminar, tendo em vista a ausência de pedido em reconvenção, é possível o reconhecimento da possibilidade de execução da indenização pelo "prejuízo que a efetivação da tutela de urgência" causou à "parte adversa" (art. 302, caput, do CPC/15), nos próprios autos. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50136755520208210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 18-11-2021).

O próprio contrato de plano de saúde do qual a autora é beneficiária expressamente prevê a exclusão do fornecimento de medicamento para uso domiciliar (Evento 24, CONTR3, fl. 10).

XIII. medicamentos para tratamento domiciliar: são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, urgência e emergência).

Dessa forma, não se mostra abusiva a negativa da operadora do plano de saúde no fornecimento do medicamento para uso domiciliar, eis que está expressamente prevista sua exclusão no contrato firmado entre as partes, bem como amparado pela legislação vigente e entendimento jurisprudencial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO CANNAB-FS 600, PARA FINS DE AMENIZAR OS SINTOMAS DA EPILEPSIA E DO COMPORTAMENTO ESTRESSADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. (...) 4) Caso dos autos em que o medicamento postulado, CANNAB-FS 600, indicado para fins de amenizar os sintomas da epilepsia e do comportamento estressado do menor, é de uso oral e destinado à ministração domiciliar. 5) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias, até o presente momento, de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, requisito necessário para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 50561775420218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 09-08-2021)

Por conseguinte, encaminha-se a improcedência da ação, com revogação da tutela de urgência deferida em sede de agravo de instrumento.

Isso posto, revogando a tutela de urgência, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação de obrigação de fazer, atribuindo à parte autora **LENISEA PEREIRA TOMASI** o pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários ao procurador da parte demandada, que fixo no valor de R$1.800,00, atualizável pelo IPCA a contar da presente sentença até o trânsito em julgado, quando passará a incidir unicamente a Taxa Selic para correção monetária e juros legais, observado o regramento dos art. 85, §2º § 16º, do CPC.

Contudo, a exigibilidade da sucumbência fica suspensa em relação à parte demandante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão de estar litigando sob o manto da gratuidade da justiça.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Intimações agendadas no sistema.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 30/09/2025, às 14:09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091979749v8** e o código CRC **bfc27cd0**.

---

1. http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_29-2018_MEDICAMENTOS%20PARA%20TRATAMENTO%20DOMICILIAR_VERSO%20FINAL_28122017.pdf ↩